

Klinik Özet - ADN_10016905

Hasta

- Cinsiyet: kadın
- Doğum tarihi: 1971-07-01
- Bölüm örneği: medikal onkoloji, medikal onkoloji, medikal onkoloji, medikal onkoloji, medikal onkoloji
- Ölüm tarihi: yok/boş

Klinik Durum

- Olası tanıları: meme karsinom, meme karsinomu Öykü: 2018 opere sol meme karsinom, meme karsinomu Öykü: 2018 opere SOL meme karsinom, meme malign neoplazm, meme malign NEOPLAZM, meme karsinomu Öykü: 2018 OPERE sol meme karsinom, MEME malign neoplazm, MEME karsinom, karsinomu Öykü: 2018 opere sol meme, karsinomu Öykü: 2018 opere SOL meme, karsinomu Öykü: 2018 OPERE sol meme
- Metastaz sahası sinyalleri: karaciğer, akciğer, kemik, beyin, lenf nodu
- ECOG: 1
- Boy/Kilo: 155 cm / 77 kg

Patoloji / Marker

```
{  
  "ER": [  
    "%40 POZIRIF",  
    "%40 pozirif"  
  ],  
  "PR": [  
    "negatif"  
  ],  
  "CERB2/HER2": [  
    "NEGATIF meme karsinomui metastazi ile uyumlu ngs ISTENDI",  
    "negatif meme karsinomui metastazi ile uyumlu ngs istendi",  
    "NEGATIF MEME karsinomui metastazi ile uyumlu ngs istendi",  
    "negatif meme karsinomui metastazi ile uyumlu"  
  ]  
}
```

Tedavi / İşlem

- Kemoterapi sinyalleri: otomatik veya robotik infüzyon kemoterapisi, otomatik veya robotik infüzyon kemoterapisi, otomatik veya robotik infüzyon kemoterapisi
- Sistemik tedavi sinyalleri: Tedavi Notu: toraks ct de met? karaciğerde met ile uyumlu lezyonlar hastadan pet ct istendi.

pet ct yeni gelişen akciğer kemik ve karaciğer met

şiddetli ağrıları var palyatif...

Lab Uyarıları

- CRP: 176.42 mg/L (high) 2023-07-06 00:00:00
- Potasyum: 0.7 mmol/L (low) 2023-07-06 00:00:00
- Kalsiyum: 3.6 mg/dL (low) 2023-07-06 00:00:00
- AST: 85.0 U/L (high) 2023-07-06 00:00:00
- Kreatinin: 144.0 mg/dL (high) 2023-07-06 00:00:00
- Sodyum: 0.29 mmol/L (low) 2023-07-06 00:00:00
- WBC: 144.0 K/uL (high) 2023-07-06 00:00:00
- NEUT#: 9.1 K/uL (high) 2023-07-06 00:00:00
- HGB: 462.0 g/dL (high) 2023-07-06 00:00:00
- PLT: 86.4 K/uL (low) 2023-07-06 00:00:00

Risk Sinyalleri

- [high] Metastaz sinyali var. | Kanıt: karaciğer, akciğer, kemik, beyin, lenf nodu
- [medium] Yatış ilişkili kayıt var. | Kanıt: işlem/yatış tipi
- [medium] CRP high | Kanıt: 176.42 mg/L 2023-07-06 00:00:00
- [high] Potasyum low | Kanıt: 0.7 mmol/L 2023-07-06 00:00:00
- [medium] Kalsiyum low | Kanıt: 3.6 mg/dL 2023-07-06 00:00:00
- [medium] AST high | Kanıt: 85.0 U/L 2023-07-06 00:00:00
- [high] Kreatinin high | Kanıt: 144.0 mg/dL 2023-07-06 00:00:00
- [high] Sodyum low | Kanıt: 0.29 mmol/L 2023-07-06 00:00:00
- [high] WBC high | Kanıt: 144.0 K/uL 2023-07-06 00:00:00
- [high] NEUT# high | Kanıt: 9.1 K/uL 2023-07-06 00:00:00
- [medium] Klinik metinde 'şiddetli' sinyali var. | Kanıt: ...e met? karacigerde met ile uyumlu lezyonlar hastadan pet ct istendi. pet CT yeni gelişen AKCIĞER kemik ve karaciger met ŞIDDETLİ ağrılari var palyatif rt için kons istendi girişimsel radyolojiden biyopsi istendi. K...

Zaman Çizelgesi İlk Kayıtlar

- 2023-07-06 10:30:00 | muayene | tıbbi onkoloji muayenesi
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | vitamin b12 (kobalamin)
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | demir bağlama kapasitesi, total
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | c reaktif protein (crp), türbidimetrik
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | ca-15-3, serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | potasyum, serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | kalsiyum, serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | bilirubin, total, serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | aspartat aminotransferaz (ast - sgot)
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | albümin, serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | alanin aminotransferaz (alt - sgpt), serum
- 2023-07-06 11:01:00 | laboratuvar | bilirubin, direkt (konjüge bilirubin), serum

SBAR

- Situation: ADN_10016905 için onkoloji ağırlıklı kayıt özeti çıkarıldı.
- Background: meme karsinom, meme karsinomu Oyku: 2018 opere sol meme karsinom, meme karsinomu Öykü: 2018 opere SOL meme karsinom
- Assessment: Metastaz sinyali var, Yatış ilişkili kayıt var, CRP high, Potasyum low
- Recommendation: Bulgular sorumlu hekim tarafından klinik dosya ve güncel tetkiklerle doğrulanmalıdır.

Not: Bu çıktı klinik karar destek amaçlıdır; tanı/tedavi kararı sorumlu hekim tarafından doğrulanmalıdır.